

 CHRU Besançon centre hospitalier régional universitaire Pôle Mère Femme	GROSSESSE ECTOPIQUE (GEU) PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE		090 URG 210 PT02 004 Version 4 Page 1 / 8
	PROTOCOLE		

1 – **Concerne** : le personnel médical intervenant aux urgences gynécologiques et en unité d'hospitalisation de gynécologie et d'hôpital de jour de gynécologie.

2 – **Bibliographie** :

- 1- HAS – Grossesse de localisation inhabituelle – Conduite à tenir devant la visualisation ou la non visualisation d'un sac ovulaire avec embryon ou vésicule vitelline - décembre 2016

[https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2017-01/dir1/ssp -
grossesses de localisation inhabituelle.pdf](https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2017-01/dir1/ssp-_grossesses_de_localisation_inhabituelle.pdf)

- 2- CNGOF – prise en charge de la grossesse extra-utérine (2003)

http://www.cngof.asso.fr/data/RCP/GEU_2003.pdf

- 3- HAS – recommandation relative à la prise en charge à titre dérogatoire du méthotrexate injectable dans le cadre d'une recommandation temporaire d'utilisation.

[https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2016-
05/methotrexate_geu_rtu_has_2016_vf.pdf](https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2016-05/methotrexate_geu_rtu_has_2016_vf.pdf)

- 4- CNGOF – Etat des lieux et expertise sur l'utilisation hors AMM du méthotrexate en gynécologie : travail du CNGOF. Avis d'experts. Huitième partie. Paris, 2014.

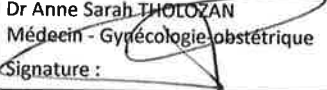
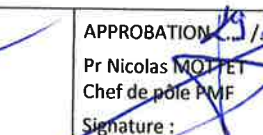
CNGOF 2014 - MISES À JOUR EN GYNÉCOLOGIE MÉDICALE

3 – **Application** :

3.1 **Définitions** :

- Une grossesse ectopique souvent appelée « grossesse extra-utérine » (GEU) est une grossesse implantée en dehors de la cavité utérine : cornuale, cervicale, sur cicatrice de césarienne, tubaire, ovarienne ou abdominale.
- Méthotrexate (MTX):
 - Mécanisme d'action :

Le méthotrexate (acide 4-amino-10-méthylfolique) est un antagoniste de l'acide folique qui inhibe la réduction de l'acide folique et la prolifération des cellules tissulaires. Le méthotrexate pénètre dans la cellule par une voie de transport actif des folates réduits. Du fait de la polyglutamation du méthotrexate induit par l'enzyme folypolyglutamylase synthétase (FPGS), la durée de l'effet cytotoxique de la substance active dans la cellule augmente. Le méthotrexate est une substance phase-dépendante dont la principale action est dirigée sur la phase S du cycle cellulaire. Il agit généralement de façon plus efficace sur les tissus en prolifération active tels que les cellules malignes, la moelle osseuse, les cellules fœtales, l'épithélium cutané, les muqueuses buccale et intestinale et les cellules de la vessie. Comme la prolifération des cellules malignes est plus importante que celles des cellules normales, le méthotrexate peut ralentir leur prolifération sans causer cependant de dommages irréversibles aux tissus sains.

Intitulé et référence du document associé : 090 URG 210 PC02 XXX			
REDACTION : 04/04/2024 Dr Anne Sarah THOLOZAN Médecin - Gynécologie-obstétrique Signature : 	VERIFICATION 04/04/2024 Celine PRETOT Cadre sage-femme Signature : 	VALIDATION  Pr Nicolas MOTTET Chef de pôle PMF Signature : 	APPROBATION  Pr Nicolas MOTTET Chef de pôle PMF Signature : 
Liste de diffusion : gynécologie, urgences gynécologiques			
Relecture périodique du document - sans modification par :		le :	

 CHRU Besançon centre hospitalier régional universitaire Pôle Mère Femme	GROSSESSE ECTOPIQUE (GEU) PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE		090 URG 210 PT02 004 Version 4 Page 2 / 8
PROTOCOLE			

3.2 Principes d'application :

Le traitement médical de la GEU donne des résultats en termes d'efficacité qui en font une véritable alternative au traitement chirurgical. Selon des indications précises, le traitement de référence est le méthotrexate (MTX).

La décision de traitement médical relève du médecin senior ou d'un chef de clinique.
Tout dossier doit être référé à un médecin senior au-delà de 3 dosages successifs de β hCG sans localisation déterminée de la grossesse en intra-utérin.

3.3 Indications :

- patiente pauci symptomatique ou asymptomatique.
- état hémodynamique stable.
- taux β hCG < 5000 UI/L.
- hémopéritoine modéré (<300cc) ou absent.
- hématosalpinx < 4 cm.
- grossesse non embryonnée.
- patiente multi-opérée.
- syndrome adhérentiel majeur.
- obésité morbide.
- contre-indication à l'anesthésie.
- GEU de siège inhabituel (interstitielle, angulaire, ovarienne, cervicale).
- échec d'une chirurgie conservatrice.
- patiente compliant, parlant et comprenant parfaitement le français.
- patiente habitant à moins de 50km du CHU de Besançon ou d'un CH avec un service de gynécologie.

3.4 Contre-indications (ANSM) :

- état hémodynamique instable (saignement actif, rupture tubaire).
- taux β hCG > 10 000 UI/L.
- hémopéritoine > 300 cc.
- hématosalpinx $\geq$ 4 cm.
- embryon avec activité cardiaque visible à l'échographie.
- contre-indications médicales au MTX : thrombopénie < 50 10⁹/L, anomalie de la coagulation sanguine, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, leucopénie < 2 10⁹/L, anémie < 9 g/100mL, clairance de la créatinine < 30mL/min.
- mauvaise compliance et adhésion de la patiente.
- domicile de la patiente à plus de 50 km du CHU de Besançon ou d'un CH avec un service de gynécologie.
- doute diagnostique.
- allaitement.
- traitement anticoagulant en cours (contre-indication à la voie IM).

ASSOCIATIONS médicamenteuses CONTRE INDIQUEES :

- ⊗ Acide acétylsalicylique à doses antalgiques (risque de majoration de la toxicité, notamment hématologique, du MTX).
- ⊗ Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients mentionnés sur la composition.
- ⊗ Abus d'alcool.

 CHRU Besançon centre hospitalier régional universitaire Pôle Mère Femme	GROSSESSE ECTOPIQUE (GEU) PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE		090 URG 210 PT02 004 Version 4 Page 3 / 8
	PROTOCOLE		

- ⌘ Altération sévère de la fonction rénale (clairance de la créatinine < 20 ml/min).
- ⌘ Dyscrasie sanguine préexistante telle qu'hypoplasie de la moelle osseuse, leucopénie, thrombocytopénie ou anémie importante.
- ⌘ Infections aiguës ou chroniques graves (telles tuberculose ou infection à VIH).
- ⌘ Probénécide, triméthoprime.
- ⌘ Vaccination concomitante par des vaccins à virus vivants.

ASSOCIATIONS médicamenteuses DECONSEILLEES (risque de majoration de toxicité hématologique)

- ⌘ Acitrétine.
- ⌘ Anti sécrétoires inhibiteurs de la pompe à protons.
- ⌘ Ciprofloxacine.
- ⌘ Pénicillines.
- ⌘ AINS (autre qu'acide acétylsalicylique qui est CI).

3.5 Bilan pré thérapeutique :

Il est à faire réaliser au CHU de Besançon dès le diagnostic de GEU pouvant être traitée médicalement.

- NFS, Plaquettes.
- TP, TCA, Fibrinogène, RAI, Groupe Rhésus.
- Ionogramme sanguin, urée, créatinine.
- ASAT, ALAT, GGT, phosphatase alcaline, LDH, bilirubine totale et conjuguée.
- BhCG quantitatif le jour de l'injection.

3.6 Schéma thérapeutique :

« **Dose unique** » : 1 injection IM de 1 mg/kg de MTX (ou 50 mg/m²) par voie intra musculaire.

3.7 Déroulement de la prise en charge :

La prise en charge se fait exclusivement en hospitalisation dans l'unité de gynécologie hospitalisation de jour (ou conventionnelle si HDJ fermée) avec une surveillance clinique pendant 2 heures après l'injection.

- Si besoin : Antalgiques de palier 1 : paracétamol, phloroglucinol. Prescription et administration dans Ideomed.
- Prévention de l'allo immunisation rhésus (patiente Rhésus négatif) par injection IV d'une dose de Rhophylac® 200µg. prescription et administration dans Ideomed.
- Surveillance de la patiente à réaliser par l'infirmière de l'unité (TA, Pouls, fréquence respiratoire, état clinique) toutes les 15 minutes pendant 1 heure puis toutes les 30 minutes. La durée d'hospitalisation est de deux heures. Alerter l'interne du service, à défaut l'interne de garde, le senior de garde devant des céphalées, troubles digestifs, dyspnée, toux, douleur thoracique.
- Validation de la sortie par l'interne du service, de garde ou le senior de garde et organisation de la suite de la prise en charge (édition du rapport d'hospitalisation, ordonnance de sortie, rendez-vous de contrôle, consignes de surveillance à domicile, n° de téléphone de l'unité de gynécologie si besoin).

 CHRU Besançon centre hospitalier régional universitaire Pôle Mère Femme	GROSSESSE ECTOPIQUE (GEU) PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE		090 URG 210 PT02 004 Version 4 Page 4 / 8
	PROTOCOLE		

☞ Au moment de la sortie, la patiente doit avoir tous ses rendez-vous de contrôle (J4, J7).

3.8 Prise en charge post hospitalisation :

Elle se réalise dans l'unité des urgences gynécologiques. La réalisation des examens biologiques se réalise au centre de prélèvement avant l'heure du rendez-vous.

Toute patiente présentant une suspicion de GEU doit être vue par un médecin senior.

- J4 post injection : évaluation clinique, échographique et biologique (β hCG).
- J7 post injection (hors w end et jours fériés, decaller au prochain jour ouvrable, 72h maximum avec accord du GO senior): évaluation clinique, échographique et biologique (β hCG, NFS plaquettes).
- Puis poursuite de la surveillance de la décroissance des β hCG une fois par semaine jusqu'à négativation en laboratoire de ville.

Le meilleur indicateur de succès du traitement par méthotrexate est une **diminution de 15% du taux de β hCG entre J4 et J7 (VPP=93%)**.

A J4, si le taux de β hCG est supérieur de 40 % au taux initial une nouvelle injection peut être indiquée : décision prise par le médecin senior.

A J4, si la décroissance est inférieure à 15% du taux initial, une nouvelle injection est programmée à J7 (après discussion avec le médecin senior de garde) avec réalisation d'un nouveau bilan biologique complet (NFS, Plaquettes, RAI, Ionogramme sanguin, urée, créatinine, ASAT, ALAT, GGT, phosphatase alcaline, LDH, bilirubine totale et conjuguée, β hCG quantitatif le jour de l'injection).

Au total, ce qui est attendu à J7 :

- Décroissance bHCG strictement < J0 ou strictement < 85% du taux de bHCG à J4.

Une exacerbation des douleurs pelviennes peut être notée dans les 24 heures post-injection et peut persister jusqu'au 4^{ème} jour, correspondant à la nécrose de la GEU.

Les indications chirurgicales définissant les échecs du traitement médical sont :

- La survenue d'un état de choc hémorragique.
- L'apparition d'un hémopéritoine important (> 300 cc).
- Des douleurs rebelles.
- Une non-décroissance du taux de β hCG après plusieurs injections de MTX.
- La persistance d'un hématosalpinx.
- Une contre-indication médicale à une nouvelle injection de MTX du fait d'effets indésirables.

EFFETS INDESIRABLES :

- ☞ Plan clinique : nausées, vomissements, douleurs abdominales (75% des patientes), stomatites, conjonctivites, effets cutanés (alopécie, toxidermie).
- ☞ Plan biologique : thrombocytopénie, insuffisance rénale ou hépatique, anomalies de la crase sanguine avant traitement contre-indiquent l'emploi du MTX. Ces effets secondaires augmentent avec le nombre de doses de MTX.

Une deuxième injection de MTX doit être envisagée si la décroissance du taux de β hCG plasmatique à J7 n'est pas satisfaisante par rapport au taux initial (en pratique le taux de β hCG à J7 devrait être strictement inférieur au taux à J0 ou strictement inférieur à 85% du taux de β hCG à J4 si celui-ci est

disponible).

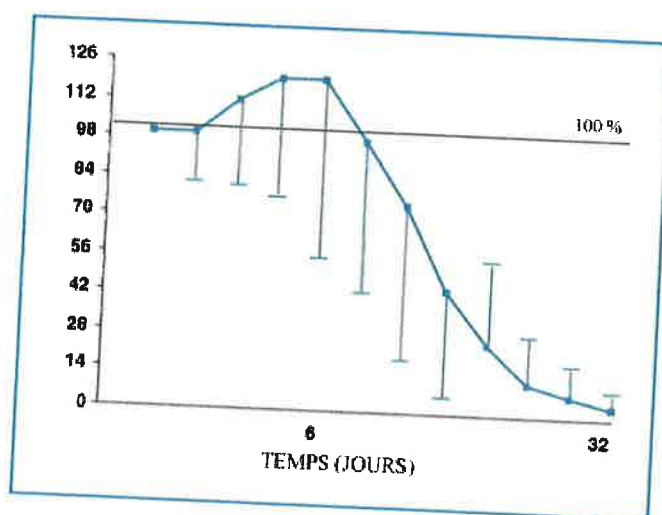
La guérison correspond à l'obtention d'un taux plasmatique d'hCG non détectable. Celle-ci est généralement obtenue au bout d'un mois.

3.9 Evolution post-thérapeutique :

Une dose additionnelle peut être décidée à J4 si le taux est supérieur de 40% au taux initial ou si le taux à J7 est supérieur à celui de J0. Ceci est à discuter avec le médecin sénior.

Dosage à J4 β hCG plasmatiques. Si la décroissance est inférieure à 15%, nouvelle injection à J7.

Dosage à J14 : si décroissance < 15%, injection répétée ou discuter prise en charge chirurgicale.



Évolution des hCG après traitement médical d'une GEU par méthotrexate.

Remarques :

Devant un taux bas de β hCG, une mauvaise cinétique, l'absence d'image intra-utérine et une patiente asymptomatique, on peut proposer en ambulatoire un curetage avec demande en urgence de villosités chorales. S'il existe des villosités, il s'agit d'une d'un avortement spontané précoce. En l'absence de villosités, on demande un nouveau dosage de β hCG. Si ce taux diminue, il s'agit d'un avortement spontané précoce. S'il augmente, une GEU est à craindre et le traitement médical peut être envisagé en cas d'absence visible de sac gestationnel.

En cas de coelioscopie « blanche » c'est à dire ne retrouvant pas de GEU intrapéritonéale ET en cas d'évolution défavorable des β hCG sur plusieurs dosages (au moins 3 dosages de β hCG ne doublant pas toutes les 48 heures dans le même laboratoire), il peut être proposé à la patiente lors de la décision de traitement un curetage utérin complémentaire de l'endomètre pour éliminer des cellules trophoblastiques (et donc une GIU). Ceci sera expliqué par le médecin senior à la patiente en cas de nécessité.

 CHRU Besançon centre hospitalier régional universitaire Pôle Mère Femme	GROSSESSE ECTOPIQUE (GEU) PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE		090 URG 210 PT02 004 Version 4 Page 6 / 8
	PROTOCOLE		

Il est proposé une contraception à J7.

J0

Indication posée d'injection de
Méthotrexate

Hospitalisation en HDJ gynécologie (ou à défaut secteur conventionnel)
Vérification ou réalisation du bilan biologique pré Méthotrexate.
Prescription d'antalgiques (Idéomed).
Prévention allo immunisation Rhésus si besoin (IDéomed).
Surveillance clinique.
Organisation de la sortie (ordonnances, rendez-vous, consignes, lettre de sortie).

J4

Evaluation clinique, échographique et biologique

Décroissance des
 β hCG < 15 %
du taux initial

NON

OUI

Programmer Nouvelle injection à
J7 avec bilan biologique complet

Augmentation
des β hCG > 40 %
du taux initial

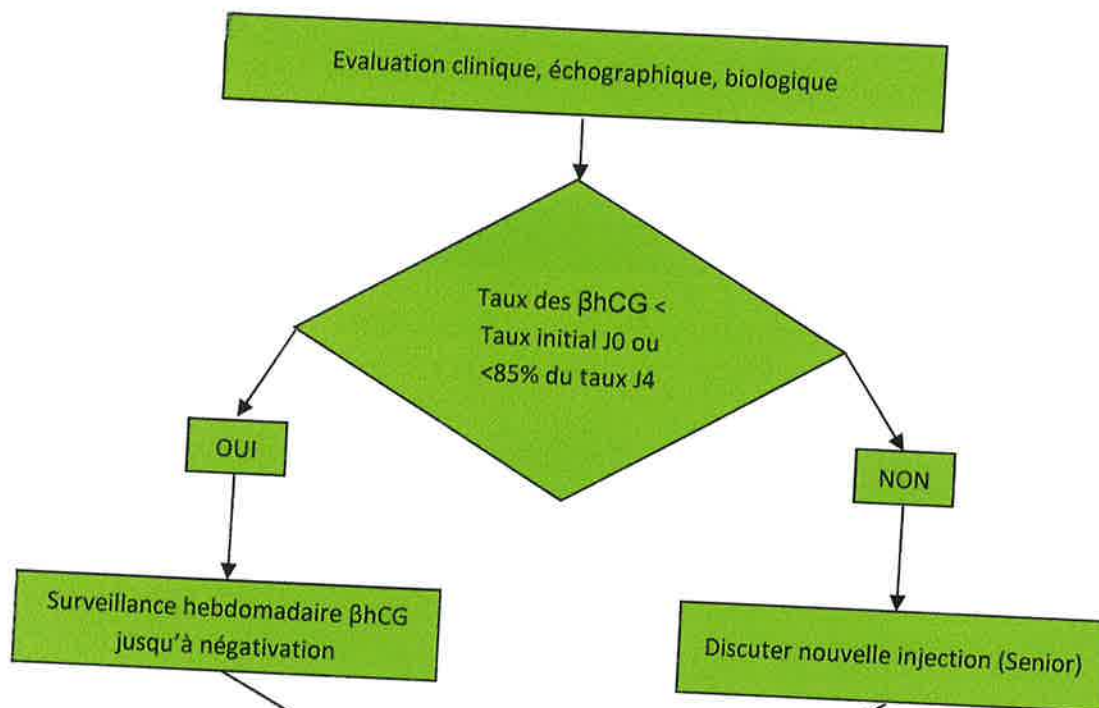
OUI

Discuter nouvelle injection (Senior)

J7

Evaluation clinique, échographique, biologique

J7



J14

